TÜRKİYE'DE ve DÜNYA'da İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

-Çağdaş uygarlık düzeyinin vazgeçilmezi sayılan bazı göstergeler.

1-Çağdaş sağlık anlayışı:

-Çağdaş sağlık anlayışında temel ilke **koruyucu hekimliktir.**

-Ülkemiz ,**1961 de kabul edilen 224 sayılı Sağlıkta Sosyalleştirme Yasası** ile, Dünya Sağlık Örgütünün **1978 Alma Ata Bildirgesi'**ndeki evrensel ilkelerde dünya ülkelerinin 17 yıl öncesine geçmiş olduğu halde yasa, her geçen gün budanmış ve şu anda yetersiz kalmıştır.

-Çağdaş sağlık anlayışında meydana gelen yetersizlikler önlenmesi gereken iş kazası, meslek hastalıkları ve tabii olarak üretkenlik düşüşünü ortaya çıkarmıştır.

Her 6 saatte 1 CAN KAYBI !!!!

Her 6 dakikada 1 İŞ KAZASI !!!!

2-Çevresel ve mesleksel hastalıklar:

-Üretimden kaynaklanan ve yalnızca bazı mesleklerde görülen hastalıklar meslek hastalığı olarak adlandırılır.

-Ülkemizde SSK 2000 yılı istatistiklerinde bu sayı sadece 803.

-Bu rakamlar gerçekçi değildir, bildirim eksikliği, gözden kaçmalar, teşhis metotlarının eksikliği, meslek hastalıkları ile uğraşan hastanelerin olmamasından veya çok az olmasından kaynaklanmaktadır.

-Yaklaşık 120 yıl önce 17 Avrupa devleti tarafından kabul edilen Berlin Konferansı'nda iş güvenliğinin de içerisinde olan 4 temel öncelik vardır.

-İş sağlığı güvenliği,

-Çocukların çalıştırılmaması,

-Sosyal güvenliğin sağlanması,

-Çalışma sürelerinin kısaltılması,

-Bu prensipler çağdaş olmanın temel taşları olarak algılanmaktadır.

Artık günümüzde bu gibi hastalıklar Çevresel ve mesleksel hastalıklar olarak görülmekte ve yavaş yavaş sağlık bozulması kavramı ortaya çıkmaktadır.

-Sevindirici gelişme ise ciddi kuruluşların bu konuda araştırmalara yönelmesidir.

Dünyada durum:

- ILO tahminlerine göre *;

- Dünyadaki işgücü : 3 Milyar
- Kadın işgücü : 1.2 Milyar
- İşle ilgili ölümler : 2.31 Milyon
- İş kazaları : 337 Milyon
- Meslek hastalıkları : 160 Milyon
- Dünya GSMH : 30 Trilyon $
- İSG kaynaklı kayıp : GSMH'nın %4'ü düzeyindedir (1.2 Trilyon $)

- (World Day for Safety and Health at Work 2009-Facts on-ILO, Safework Introductory Report-2008-ILO)
- (*2003 yılı verileri kullanılarak, 2005-2006 yılında yapılan tahminler)

3-Kütüphane olanaklarından yararlanma:

-Ülkemizde bu konu ile ilgili bir tek yararlanılacak adres bulunmaktadır. Dr. Nusret Fişek Enstitüsü. İnternet üzerinden de ulaşılabilen bu bilgiler dışında bu konularda araştırma yapılabilecek fazla kaynak yoktur.

4-Kayıt ve İstatistiki bilgiler:

-Gelişmiş ülkeler 100-150 yıllık verilerle konuşurken, biz 2000'li yıllarda istatistikleri konuşamamaktayız, sosyal güvenliği olanların bilgilerine bile ulaşamazken, ülkemizde sosyal güvenlikten yoksun çalışan yaklaşık % 19' luk bir kesim vardır.

5-Öngörü:

-Ülkemizde genellikle günübirlik yaşama gibi bir tarz var. Kurumsal yapılarda da genellikle işler bu şekilde yürümektedir.

-Ancak son yıllarda bizleri umutlandıran bazı gelişmelere de tanık olmaktayız.

Mesela DPT tarafından hazırlanan son Beş Yıllık Kalkınma Planlarında 'İş Sağlığı ve Güvenliği' ,özel bir ihtisas komisyonuna bağlı alt çalışma grubu olarak toplanmış ve öngörüler içeren değerli çalışmalar yapılmıştır.

6-Grupçu çözüm:

-İş sağlığı ve güvenliğinde bireyselliğe yer yoktur.

-Bu alanda birbirleri ile organik bağları olmayan işyerlerinin bir araya gelerek 'işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimi' oluşturmaları çok yeni kavramdır.

-Bundan 25 yıl kadar önce ülkemizde Dr. Nusret Fişek Enstitüsü'nün bu alanda çalışmaları olmuş, hatta bu çalışma 1996 yılında BM 'İnsan Yerleşimleri Konferansı'nda En İyi Uygulama olarak gösterilmiştir.

- Özellikle çalışma koşullarının ve bundan kaynaklanan sorunların çözümünde çok fazla zorluklarla karşı karşıya kalan KOBİ'lerin grupçu çözümler bulamaması başarısızlıklara neden olmaktadır.

- Yeni yasa bu konuda iyi bir çözüm gibi görülmektedir.

- Üniversitelerimizin Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinde okuyan öğrencilere zorunlu İSG dersleri konması güvenlik bilinci oluşturma hedefine yönelik önemli bir adımdır.

7-Çok Bilimlilik ve Bütünsellik:

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda bir çok bilim dalı çalışmalar yapmaktadır, bu konuda başarı ancak birliktelik ile gelecektir.

-Yalnız doktorların,veya psikologların veya mühendis veya hukukçuların katkısı bu devasa konudaki gereksinimleri karşılayamaz.

-Bilimsellik yerine pragmatik ve popülist yaklaşımlar ile işler yürütülmek istenmiştir.

-Bu nedenledir ki iş kazaları dikkatsizliklere bağlanmakta meslek hastalıkları ise tanı bile koyulamadan kaydedilmektedir.

-Tüm bu neticelere verdiğimiz istatistikler nedeni ile varmaktayız.

10-Birbirini denetleme:

-İş yerlerinde bireyler hiçbir zaman tek başlarına değildirler, bu nedenle bir kişinin yaptığı diğer çalışanları da etkilemektedir.

-Kendini korumak ya da yakın çevresini ve geleceğini korumak adına diğer çalışanların eylemlerine sınır istemek veya kendini tehlikeye veya olumsuz bir duruma sokacak diğerlerinin eylemlerini şikayet etmek çok normal bir durumdur.

-Ancak bizim işyerlerimizde şikayetler, hatta başkalarını şikayet pek hoş görülen bir olay değildir.

-Uygar ülkelerde bu böyle değildir.

-Ayrıca kurumların birbirini,veya aynı kurumun çeşitli bölüm veya kuruluşlarının birbirlerini denetlemeleri, artık normal prosedürler haline gelmektedir. İSO denetimleri gibi.

8-Katılımcılık:

-Bu gün gelinen noktada karar alma aşamasında konunun tüm taraflarının katılımı aranmaktadır. Çalışma yaşamında karar alma süreçlerinde, denetimlerde zenginliğin olması için tüm tarafların katılımı şarttır.

- İşyerlerinde tehlike sınıfına göre her ay, 2 ayda veya 3 ayda bir toplanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında, işyeri hekimi ve işçilerin seçtiği işçi temsilcisi, de bulunmaktadır.

-Hiç şüphesiz ki sağlıksız ve güvensiz çalışma koşullarının acısını en çok çalışan işçiler çekmektedir.

11-İnsan odaklı yaklaşım ve tüketici:

-Üreten işyerlerinin üretimlerini pazarladıkları tüketiciler ile her zaman karşı karşıya gelmeleri gerekmektedir zaten olayın doğası da budur.

Özellikle gelişmiş ülkelerde **'tüketici odaklı yaklaşım'** iş sağlığı ve güvenliği alanında en etkili denetim mekanizmalarından biridir.

9-Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik:

-Birbirini tamamlayan bu iki kavram aynı zamanda insana saygıyı da yansıtmaktadır. Her insan yaşamı boyunca gereksinimlerinin karşılanmasında istikrar ve güvenceyi hak etmektedir.

-Ancak bunu sağlayabilmek için kurumların kimliklerinin yerini bulması ve süreklilik kazanması gerekmektedir.

-İşçi örgütleri, işveren örgütleri hatta devlet sözlü değil yazılı **kurumsal bellekler** oluşturmalı ve bunların sürdürülebilir olmasını sağlamalıdır.

-Tabii bu kurumsal belleklerin sürekli olması için **tutarlılık** esastır.

-Sağlıklı ve güvenilir bir ortamda çalışan işçilerin ürettiği malların tercih edilmesi giderek yaygınlaşan bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktadır ki gelişmiş ülkelerdeki bu uygulamaların ülkemizde de görülmeye başlaması sevindiricidir.

12-Uluslararası denetim mekanizmalarının ağırlık kazanması:

-Rekabet eşitsizliği yaratmamak ve insan haklarına saygılı bir toplum yaratma istemi, iş sağlığı ve güvenliğinde de ağırlığını hissettirmiştir.

-Şu anda ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çabaları sevindirici olmakla beraber Türkiye'nin notu bu 12 başlık olmak üzere tam puan olan toplam 60'a yaklaşamamış ve ancak 11 de kalmıştır.

-Bu konuda çok sevindirici bir olay; 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2011 yılı eylül ayında Türkiye'de yapılmıştır.

-1802 yılında ülkemizde Çırakların Bedeni ve Manevi Sağlıkları Hakkındaki Kanun ile başlayan ulusal mevzuata, 1890 Berlin Konferansında eklenen Uluslararası Mevzuat, 1919 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun kurulması ve üye ülkeler tarafından kabul edilen sözleşmeler çalışma hayatı için bir standart niteliği taşımıştır.

Ülkemizde İyi örnekler de var.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) tarafından düzenlenen 9. Avrupa İyi Uygulama Örnekleri Yarışmasında Ereğli Demir Çelik İşletmesi **sağlık ve güvenlik alanında en iyi uygulama** ödülünü almıştır.

- 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu konuda bir çok Uluslararası örgüt kurulmuş ve bunların sözleşmeleri, karar ve belgeleri üye ülkeleri de bağlar duruma getirmiştir.

- Ülkemiz tüm bu organizasyonların dışında kalmamış, ancak diğer üye ülkelerin hızla yaşama geçirdiği kararları uygulamada bazı sıkıntılar yaşamıştır.

Dünyada durum:

- ILO tahminlerine göre *;

- Dünyadaki işgücü : 3 Milyar
- Kadın işgücü : 1.2 Milyar
- İşle ilgili ölümler : 2.31 Milyon
- İş kazaları : 337 Milyon
- Meslek hastalıkları : 160 Milyon
- Dünya GSMH : 30 Trilyon $
- İSG kaynaklı kayıp : GSMH'nın %4'ü düzeyindedir (1.2 Trilyon $)
- (World Day for Safety and Health at Work 2009-Facts on-ILO, Safework Introductory Report-2008-ILO)

- (*2003 yılı verileri kullanılarak, 2005-2006 yılında yapılan tahminler)

Dünyada durum:

İLO rakamlarına göre:

- **Her yıl 270 milyon iş kazası,**
- **Her yıl 2 milyon 200 bin can kaybı,**
- **Her gün yaklaşık 6000 kişi iş kazası veya meslek hastalığı dolayısı ile ölüyor.**
- **Yılda 350 bin iş kazasından,**
- **1 milyon 700 bin meslek hastalığı dolayısı ile ölüm var.**
- **Her yıl 160 milyon kişide çalışmadan kaynaklı meslek hastalığı,**

- **Silikozis her yıl on milyonlarca işçiyi etkilemektedir.**

- **Latin Amerika'da maden işçilerinin %37 si, bu oran 50 yaş üzerinde % 50 dir.**

- **Hindistan'da taş işçilerinin %50 si ve taş kırma işçilerinin % 36 sı silikozise yakalanmaktadır.**

- **Her yıl inşaat sektöründe 60 bin ölümcül kaza yaşanmaktadır.**

- **Her 10 dakikada 1 can kaybı.**

- **ILO verilerine göre Dünyadaki bütün ölümlerin %3.9'u iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olmaktadır.**
- **Dünya nüfusunun %15'i iş kazası veya meslek hastalıklarına maruz kalmaktadır.**
- **Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre dünyada her yıl 11.000.000 yeni meslek hastalığı vakası meydana gelmekte ve bunların 700.000'i hayatını kaybetmektedir.**
- **İngiltere'de yapılan ulusal ölçekli bir çalışmayla yüz bin işçiden 4'ünde mesleki astım, 15'inde mesleki deri hastalığı saptanmıştır.**

Türkiye'de durum:

-4857 sayılı yasa ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsamaktadır, ancak mühendislik ve hekimlik uygulamalarına ilişkin yasal eksiklikler, işverenlerin konuya gerekli önemi vermemesi, kayıt dışı istihdam, hatta son yıllarda bilhassa turizm bölgelerinde yabancıların da kayıt dışılığa eklenmesi, kadın ve çocuk sömürüsü ile kayıt dışı ekonominin büyüklüğü yasanın tam olarak uygulanmasında zorluklar ortaya çıkarmaktadır.

- Dünya nüfusunun %15'i iş kazası veya meslek hastalıklarına maruz kalmaktadır.

- Halen işsiz olan işgücünün %30'u daha önceki işleri sırasında meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle yeniden iş bulmakta güçlük çekmektedir

- Her yıl zehirli maddelerden dolayı 438 bin can kaybı, dünyada meydana gelen cilt kanseri hastalıklarının %10' u işyerlerindeki zehirli madde temaslarından oluşuyor.

- Her yıl asbest yüzünden 100 bin işçi yaşamını kaybediyor.

-Çalışma yaşamındaki ilkel koşullar ve iş sağlığı ve güvenliğinin ciddiye alınmaması ülkemizi ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları ile meslek hastalıklarında rekora koşturmaktadır.

-Yakın zamanda İstanbul Davutpaşa'daki büyük bir fabrika yangını,Tuzla tersanelerinde ki ölümler ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliğinin ne durumda olduğunun göstergesidir.

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler işçi sayısı 50 den az olan yerlerde sağlık birimi zorunluluğu getirmemektedir.

- Ülkemizdeki işyerlerinin %98.5'i 50 den az işçi çalıştırmaktadır.

- Toplam bu hizmeti alan şanslı çalışanlar sadece % 1.5 tir.

-1997 yılında iş ve meslek hastalıklarından 1473 ölüm,

-2006 yılında 1601 ölüm,

-79027 İş kazası,

-2267 sakat(sürekli iş göremez),

-574 meslek hastalığı,

-Ayrıca çalışanların sadece %35'i SSK'lıdır.

- TÜİK istatistiklerine göre ülkemizde çalışanların % 43'ü kayıtdışıdır.
- TÜİK'in bir araştırmasında, bir yıl içinde istihdam edilenlerin % 2,9'unun işle ilgili kaza veya rahatsızlığa maruz kaldığı tespit edilmiştir.
- TÜİK araştırmalarına göre
- Ülkemizde her yıl iş kazası geçiren kişi sayısı yılda 600 bin civarında olabilir.

32

-Bildirilmeyen iş kazaları en az birkaç kat, teşhis konulamayan meslek hastalıkları sayısı veya oranı ise bilinemiyor.

-En fazla kaza yaşanan sektör metal eşya imalatı 10283,

-En fazla ölüm inşaat sektörü 290,

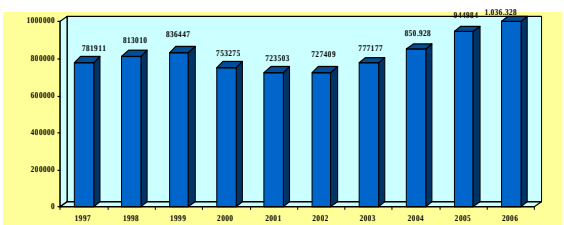
-Garip ama gerçek bilinmeyen kategorisi %32 ile birinci.

-En fazla iş kazası sırası ile İstanbul, İzmir ve Bursa,

-Sürekli iş görmezlik raporlarında Zonguldak 244 ile ikinci.

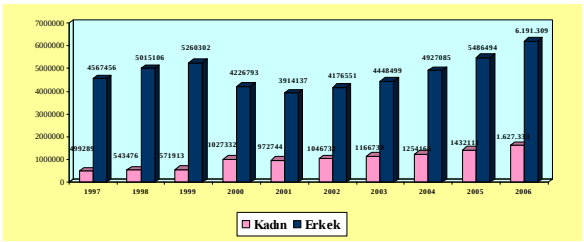
-Ülkemizde iş kazalarının %60'ı , 50 den az işçi çalıştıran KOBİ'lerde, hatta bunların da %50'si, 9 veya daha az işçisi olan işletmelerde meydana gelmektedir.

-İleri ülkelerde çalışma saatleri azalırken,bizde değişmemektedir.



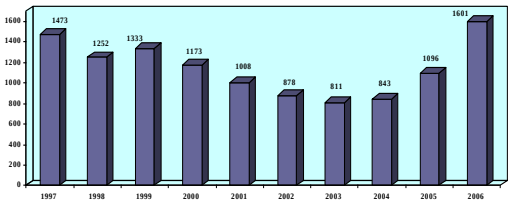
Yukarıdaki istatistik 2006 yılı SSK istatistiklerinden alınmış ve Türkiye'de ki işyeri sayılarını göstermektedir.

1997 yılında 800 bine yakın işyeri varken 2001 yılında 720 binlere kadar düşmüş ancak 2006 yılında 1 milyon işyeri sayısını geçmiştir.

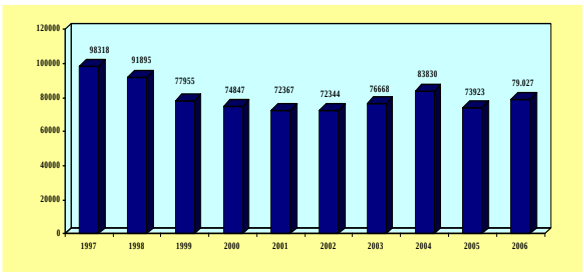


Tabloda işçi sayılarının kadın erkek oranları ve 1997 yılı ile 2006 yılları arasındaki değişimler görülmektedir.

1997 yılında 4.5 milyon işçinin yaklaşık onda biri kadar kadın sayısı varken işçi sayısı 2006 yılında 6 milyon işçi sayısını geçmiş ve erkek kadın işçi oranı dörtte bire çıkmıştır.

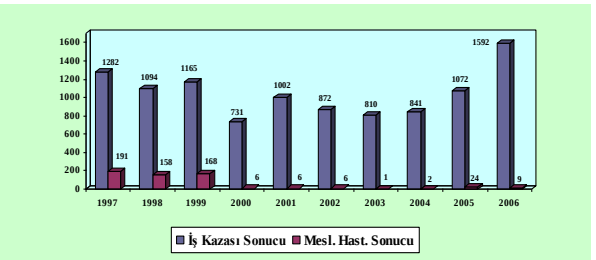


Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarından 1997 yılı ile 2006 yılları arasında ölüm sayıları.



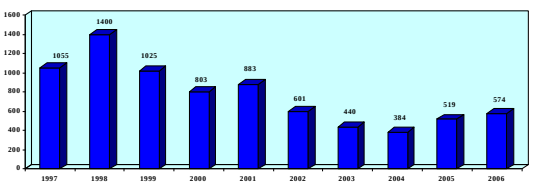
Tablo 1997 yılı ile 2006 yılları arasındaki iş kazası sayılarını göstermektedir.

Ülkemizde 1997 yılında 98318 olan iş kazası sayısı 2006 yılında SSK verilerine göre 79027 ye düşmüş görülmektedir.



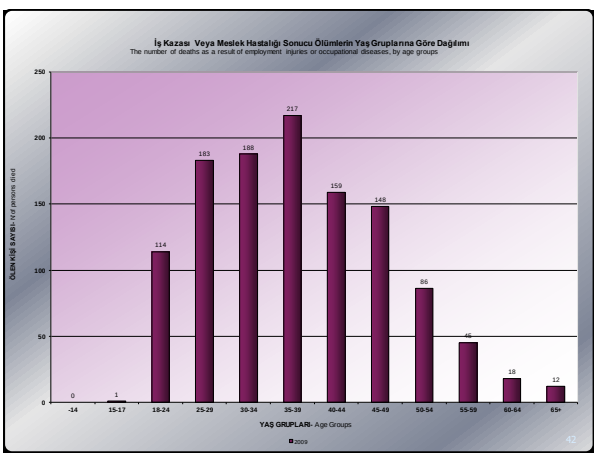
Tablo ölümlerin ölüm sebebine göre dağılımını göstermektedir.

1999 yılından sonra Ülkemizde meslek hastalıklarından ölüm çok azalmış görülmektedir. Peki realite sizce bu mu?



Tablo 1997 yılı ile 2006 yılı arasındaki 10 yıllık süre içindeki meslek hastalıkları sayılarını göstermektedir.

6 milyonun üzerinde işçi sayısı olan bir ülkede meslek hastalıklarının bu kadar düşük sayıda kalmasının nedenlerinin büyük bir dikkatle araştırılması gerekmektedir.



- 2009 yılı SSK verilerine göre iş kazası sayısı 64.316

- Bu kazalar sebebiyle 1.171 ölüm!!!!

-2009 yılı SGK istatistiklerine göre meslek hastalıkları vaka sayısı ise 429'dur.

- 2011 yılı SSK verilerine göre iş kazası sayısı 69227,

- Bu "kaza"larda 1700 işçi yaşamını yitirdi!!!!

- 2011'de 697 işçide ise meslek hastalığı tespit edildi.

B) 2013 YILI İSTATİSTİKLERİ (gayriresmi)

- Basın ve emek-meslek örgütleri ve işçilerden gelen bilgiler doğrultusunda 2013 yılında en az **1235 işçi yaşamını yitirdi**. Ölen işçilerden **103'ü kadın 1132'ü erkek** idi. Bunlardan **59'u çocuk, 22'si göçmendi.**

- Şehirlerde İstanbul başı çekerken, en çok ölüm inşaat sektöründe kaydedildi. **Mayıs ayıyla birlikte** mevsimlik işçilik artmaya başladığı için ölümler de bu aydan itibaren yükselmeye başladı.

- Aylara göre dağılım şöyle: Ocak 81, Şubat 60, Mart 74, Nisan 74, Mayıs 114, Haziran 104, **Temmuz 120, Ağustos 130, Eylül 124, Ekim 113, Kasım 129** ve Aralık 112.

46

Dönemi	İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Toplam Ölüm Sayısı*	İş Kazasına Bağlı Ölümler*	Meslek Hastalığına Bağlı Ölümler*
2012	745	744	1
2011	1 710	1 700	10
2010	1 454	1 444	10
2009	1 171	1 171	0
2008	866	865	1
2007	1 044	1 043	1
2006	1 601	1 592	9
2005	1 096	1 072	24
2004	843	841	2
2003	811	810	1
2002	878	872	6
2001		1 008	
2000		1 173	
1999			

2013 1235 (gayriresmi)

2014 / ilk yarı 978 (gayriresmi)

44

2014'ÜN İLK ALTI AYINA AİT İSTATİSTİKLER (gayriresmi)

- **2014'ün ilk yarısında meydana gelen iş kazalarında 978 çalışan yaşamını yitirdi. Bunların 40'ı kadın, 19'u çocuk, 18'i göçmen ve 150'si emeklilik çağında çalışıyordu.**

- **Yaşamını yitirenlerin 325'i maden, 187'si inşaat, 122'si tarım ve 79'u taşımacılık işkolunda çalışıyordu.**

- **Ölümlerin 324'ü Manisa, 82'si İstanbul, 34'ü Kocaeli, 31'i Ankara ve 31'i Bursa'da vuku buldu.**

- **Yaşamını yitiren çalışanların 889'u işçi/kamu çalışanı/memur statüsünde ücretlilerden; 89'u çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve kendi hesabına çalışan esnaftan oluşmaktadır.**

47

- SGK verilerindeki meslek hastalığı vaka sayısı çok düşüktür. 2007 yılı istatistiklerine göre 1.208, 2008 yılında 539, 2009 yılında 429, 2010 yılında 533, 2012'de ise 395 meslek hastalığı vakası tespit edilmiştir.

- Meslek hastalıkları vaka sayılarının düşük çıkmasının nedeni meslek hastalığı olgularının saptanamamasıdır.
- Oysa gelişmiş ülkelerde, örneğin Almanya'da her yıl 40.000, ABD'de 400.000 dolayında meslek hastalığı olgusunun rapor edildiği bilinmektedir. Bu paralelde bir hesaplama yapılacak olunursa, Türkiye'de 20.000 kadar meslek hastalığı vakası olabileceği varsayılabilir.
- Ülkemizde halen İstanbul, Ankara ve Zonguldak'ta olmak üzere Üç Meslek Hastalıkları Hastanesi bulunmaktadır. Meslek hastalıkları olgusu sayısının yüzde 80'inden fazlası bu üç ilde görülmektedir. Oysa toplam işyerlerinin ve işçilerin ancak yüzde 40'ı bu 3 ilde bulunmaktadır. Adana, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep gibi sanayileşmiş, işçilerin yoğun olarak çalıştıkları iller meslek hastalıkları hastanelerinden yoksundur.

45